



Pasuruan, 23 Oktober 2024

Nomor : 1211/RSPHS/I-UND/KMKP/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Undangan RCA Pasien Ny Sumiati

Kepada Yth.

1. dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS - Direktur RSPH Sukorejo
2. Heni Indra Wulansari, S.Kep.Ns, M.Kep - Kabid Pelayanan
3. Dwi Novianti. A.Md.AK., S.Kes – Kabid Penunjang
4. Siti Maysaroh, Amd. Kep – Kabid Keperawatan
5. Novia Ainur Pratiwi, S.KM. – Kepala SDM
6. dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD – Komite Medik
7. Rofi'atal Manzilah, S.Psi – Sekre Komdik & Diklat
8. Allamul Angga Gilang Nishvu Ramadhan, S. Kep., Ns – Komite Keperawatan
9. dr. Fina Jazilah Rizqiyah (Dokter IGD)
10. dr. Santoso Rahardjo, Sp.OG (DPJP)
11. dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG (Dokter Obgyn)
12. Ninis Indrawati, S.Tr. Keb. (Karu Maternitas)
13. Novi Nur Cholifah, Amd. Keb (Bidan Ponek)
14. Karunia Rizqi Nurandini, S.Tr.Keb (Bidan Maternitas)
15. Nurul Komariyah, Amd. Keb (Bidan Maternitas)

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien yakni Ny. Sumiati dengan PEB yang dirujuk ke RS Saiful Anwar Malang dan Pasien meninggal di RS Saiful Anwar, maka Kami mengundang untuk *Root Cause Analysis* pada :

Hari / tanggal : Kamis/ 24 Oktober 2024
Pukul : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Andalusia, Lantai 3
Materi : RCA Pasien Ny. Sumiati

Demikian undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya kegiatan tersebut maka **wajib** untuk hadir dengan **membawa rekam medis pasien**. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Komite PMKP

Lidia Puspita Kencana, S.K.M.

Formulir Laporan Insiden Internal ke Tim KP di RS

NO. IKP : 328

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAXIMAL 2 x 24 JAM

LAPORAN INSIDEN
(INTERNAL)

I. DATA PASIEN

Nama : Sumiati

No. RM : 105461

Ruangan : IGD-Ponek & Cempaka 2C.1.1

Umur * :

☐ 0-1 bulan

☐ > 1 bulan – 1 tahun

☐ > 1 tahun – 5 tahun

☐ > 5 tahun – 15 tahun

☐ > 15 tahun – 30 tahun

☒ > 30 tahun – 65 tahun (32 Th)

☐ > 65 tahun

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki

Penanggung Biaya Pasien :

☐ Pribadi

☒ BPJS

☐ Asuransi Swasta

☐ Lainnya (sebutkan)

Tanggal Masuk RS : 04 Oktober 2024

Petugas Saat Insiden:

1. dr. Fina Jazilah Rizqiyah (Dokter IGD)

2. dr. Santoso Rahardjo, Sp.OG (Dokter Obgyn)

3. Ninis Indrawati, S.Tr. Keb. (Karu Maternitas)

4. Novi Nur Cholifah, Amd. Keb (Bidan Ponek)

5. Karunia Rizqi Nurandini, S.Tr.Keb (Bidan Maternitas)

6. Nurul Komariyah, Amd. Keb (Bidan Maternitas)

II. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden
Tanggal : 04 Oktober 2024 (02.15 WIB)

2. Insiden :

Pasien Ny. Sumiati mengalami PEB saat masuk di RS Prima Husada Sukorejo

3. Kronologis Insiden

Hari / Tanggal	Jam	Tindakan	Bukti
Rabu/02 Oktober 2024	10:05 WIB	- Pasien datang ke poli kandungan untuk memeriksakan kehamilannya karena ada keluhan pusing. - Pasien ditensi, tanpa melihat buku KIA. (Catatan di buku KIA: hasil pemeriksaan di puskesmas protein urine positif 4) - Pasien di TD awal dengan hasil 140/90 setelah itu pasien disuruh miring kiri 5 menit kemudian pasien di TD dengan hasil 110/80 mmg. Karena tensi normal maka Cuma di beri obat elkana. - Pasien dianjurkan kontrol lagi tanggal 16/10/2024.	



Jum'at/ 04 Oktober 2024	03:00 WIB	Pasien datang di IGD dengan keluhan sejak 4 hari ini pusing, nyeri uluh hati, mual, muntah 3x hari ini Alergi:- RPD : DM (-) HT (-) RPO:- HPHT: 27.01.2024 TP: 04:11:2024 Pemeriksaan Fisik TD:170/100 mmHg Nadi: 88x/menit RR : 20 x/menit Suhu: 37,2 Djj : 144x/menit on nc 4 lpm BB: 67kg TB : 151 cm TFU :28 cm His : tidak ada VT : Pembukaan tidak ada Riwayat Obstetry: 1. Aterm/ normal/ bidan/ pkm/3500gram/14th/laki laki 2. Hamil ini Pemeriksaan Penunjang : DL, FL, UL NST Diagnosis kerja : G2P1AB0 UK 32-34 MINGGU dengan PEB Terapi IGD : Inf RL 20 tpm Nifedipine 10 mg (SL)
	04:00 WIB	Telp dokter Santoso Sp.OG lapor pasien dapat terapi nifedipine 10 mg(SL), konfirmasi apakah ada terapi MgSo40% tidak, itu saja dulu dan direncanakan sc setelah sholat jumat, jika pasien tidak setuju sc maka pasien direncanakan rujuk saja.
	05:50 WIB	Konfirmasi anastesi dr Heru Sp.An jika ada rencana SC dapat premed ondancentron 4 mg dan dexamethasone 10mg acc sc setelah sholat jumat.
	06:05 WIB	Konfirmasi maternitas pasien naik ruangan, dan operan dengan bidan maternitas
	06:15 WIB	Pasien sampai di maternitas dan melakukan operan Ku cukup : TD:170/100 mmHg Nadi: 80x/menit RR : 20 x/menit Suhu: 36,5 Djj : 144x/menit on nc 4 lpm His : tidak ada

Hasil Pemeriksaan Laboratorium:



RUMAH SAKIT

PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

Nama Pasien

: SUMIATI

Tgl. Lahir/Umrur

: 03/12/1991 / 32 th 10 bln 1 hr

Alamat

: GUNINGSARI RT. 02 RW. 07 KEL. KERTOSARI Kec. PURWOSARI
KAB PASURUAN JAWA TIMUR

Cara Bayar

: BPJS KESEHATAN

Atas / Pengirim

: Instalasi Gawat Darurat / dr. Fina Jazilah Rizqiyah

No. RM

: 105461

Jns. Kel.

: Perempuan

No. Labo

: 24110040005

Spesimen

: Darah

Tgl/Jam diambil

: 04-Okt-2024 / 02:46

Tgl/Jam diterima

: 04-Okt-2024 / 02:46

Tgl/Jam Selesai

: 04-Okt-2024 / 05:50

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Rujukan	Keterangan
HEMATOLOGI				
Hemoglobin	12,2	g/dL	L 13,3-17,7 P 11,7-15,7	
Hitung Lekosit	12.100	cell/cmm	4.000 - 11.000	
LED	30	mm/jam	L <= 15 P <= 20	
Hitung Jenis				
Eosinofil	1	%	2 - 4	
Basofil	0	%	0 - 1	
Neutrofil	83	%	50 - 70	
Limfosit	13	%	25 - 40	
Monosit	3	%	2 - 8	
Hitung Trombosit	198.000	cell/cmm	150.000 - 450.000	
Hematokrit	36,5	%	L 40-54 P 35-47	
Hitung Eritrosit	3,78	10 ⁶ /cmm	L 4,5 - 6,5 P 3,0 - 6,0	
MCV	97	fL	80 - 97	
MCH	32,2	pg	27 - 34	
MCHC	33,3	g/dL	32 - 36	
PPT	13,4	Detik	11 - 15	
aPTT	31,5	Detik	25 - 40	

Kesan / Kesimpulan :

Pasuruan, 04/10/2024

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
Jenis Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Rujukan	Keterangan
URINALISIS				
Makroskopis				
Warna	Kuning Tua		Kuning muda	
Keruh			Jernih	
Kadaban	Negatif	/LPK	Negatif	
Lekosit	Negatif	mg/dL	Negatif	
Keton	Negatif	mg/dL	Negatif	
Nitrit	Negatif		Negatif	
Billirubin	Negatif		Negatif	
Blood	Negatif		Negatif	
Protein	+4		Negatif	
Glukosa	Negatif	mg/dL	Negatif	
Berat Jenis	1,025		1,000 - 1,030	
pH	6,0		5 - 9	
Mikroskopis				
Slinder	Negatif	/LPK	Negatif	
Eritrosit	0 - 1	sel/LPB	0 - 1	
Lekosit	1 - 2	sel/LPB	0 - 1	
Epitel	+2	/LPB	Negatif	
	Squamous			
Kristal	+1 Ca Oxalat		Negatif	
Bakteri	+2 Batang, Coccus		Negatif	
Lain-Lain	Negatif		Negatif	
Kesan / Kesimpulan :				



	07:05 WIB	Operan dengan sift pagi. Keluarga teriak karena pasien kejang ada di kamar. Pasien di pindah ke gynec, pasang monitor, GCS 426 TD : 170/80 N : 100X/M RR : 30X/m pasang oksigen NRBM 10 lpm pasang DC (urien +- 10cc warna coklat gelap). Telpn dokter IGD, konsul DPJP, Advis MGSO4 drip 40 %, IV 20 %. Karena tidak jelas terkait dosis maka bidan mater telpn dokter rudi, advis MGSO4 advis MGSO4 full dose (40% 4gr (10cc+WI 10cc), 6gr MgSO4 40% (15cc) drip NS 500cc masuk dengan pelan lalu rujuk.	
	07:37	Menghubungi hotline RSSA untuk merujuk pasien.	
	08:10	Acc berangkat	

4. Jenis Insiden* :

- ☐ Kondisi Potensial Cedera / KPC
☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
☐ Kejadian Tidak Cedera / KTC
☒ **Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)**
☐ Kejadian Sentinel (Sentinel Event)

5. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*

- ☒ **Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya**
☐ Pasien
☐ Keluarga / Pendamping pasien
☐ Pengunjung
☐ Lain-lain(sebutkan)

6. Insiden terjadi pada* :

- ☒ **Pasien**
☐ Lain-lain(sebutkan)
Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3RS.

7. Insiden menyangkut pasien :

- ☐ Pasien rawat inap
☐ Pasien rawat jalan
☒ **Pasien IGD**
☐ Lain-lain(sebutkan)

8. Tempat Insiden

IGD-Ponek & Cempaka 2C.1.1 (Tempat pasien berada)

9. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)

- ☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
☐ Anak dan Subspesialisasinya
☐ Bedah dan Subspesialisasinya
☒ **Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya**
☐ THT dan Subspesialisasinya
☐ Mata dan Subspesialisasinya
☐ Saraf dan Subspesialisasinya
☐ Anestesi dan Subspesialisasinya
☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya



- ☐ Jantung dan Subspesialisasinya
- ☐ Paru dan Subspesialisasinya
- ☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
- ☐ Lain-lain (sebutkan)

10. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden
Unit kerja penyebab

11. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
- ☐ Kematian
 - ☒ **Cedera Irreversibel / Cedera Berat**
 - ☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
 - ☐ Cedera Ringan
 - ☐ Tidak ada cedera

12. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
a. Konsultasi ke Dokter Rudi terkait pemberian dosis MgSO4 dan NS 500 cc
b. Rujuk ke RSSA

13. Tindakan dilakukan oleh* :
- ☐ Tim, terdiri dari :
 - ☒ **Dokter**
 - ☐ Perawat
 - ☒ **Petugas lainnya**

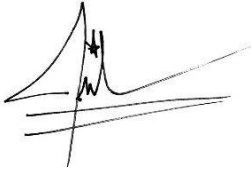
14. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*

- ☐ Ya
- ☒ **Tidak**

Apabila Ya, isi bagian dibawah ini.

Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?

.....
.....
.....

Pembuat Laporan	: Ninis Indrawati, S.Tr. Keb.	Penerima Laporan	: Lidia Puspita Kencana, S.K.M.
Paraf		Paraf	
Tgl Lapor	: 19 Oktober 20274	Tgl terima	: 19 Oktober 2024

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :

- ☐ **BIRU**
- ☐ **HIJAU**
- ☐ **KUNING**
- ☒ **MERAH**

NB. * = pilih satu jawaban

I. ANALISA PENYEBAB INSIDEN

Dalam pengisian penyebab langsung atau akar penyebab masalah dapat menggunakan Faktor kontributor (bisa pilih lebih dari 1)

FAKTOR KONTRIBUTOR EKSTERNAL / DI LUAR RS	
a. Regulator dan Ekonomi b. Peraturan & Kebijakan Depkes c. Peraturan Nasional d. Hubungan dengan Organisasi lain	
FAKTOR KONTRIBUTOR ORGANISASI & MANAJEMEN	
Organisasi & Manajemen	a. Struktur Organisasi b. Pengawasan c. Jenjang Pengambilan Keputusan
Kebijakan, Standar & Tujuan	a. Tujuan & Misi b. Penyusunan Fungsi Manajemen c. Kontrak Service d. Sumber Keuangan e. Pelayanan Informasi f. Kebijakan diklat g. Prosedur & Kebijakan



	h. Fasilitas & Perlengkapan i. Manajemen Risiko j. Manajemen K3 k. Quality Improvement
Administrasi	Sistem Administrasi
Budaya Keselamatan	a. Attitude kerja b. Dukungan manajemen oleh seluruh staf
SDM	a. Ketersediaan b. Tingkat Pendidikan & Keterampilan Staf yang berbeda c. Beban Kerja yang optimal
Diklat	Manajemen Training Pelatihan / <i>Refreshing</i>
FAKTOR LINGKUNGAN KERJA	
Desain dan Bangunan	a. Manajemen Pemeliharaan b. Penilaian Ergonomik c. Fungsionalitas
Lingkungan	a. Housekeeping b. Pengawasan Lingkungan Fisik c. Perpindahan Pasien antar Ruang
Peralatan / sarana / prasarana	a. Malfungsi Alat b. Ketidaktersediaan c. Manajemen Pemeliharaan d. Fungsionalitas e. Desain, Penggunaan & Pemeliharaan peralatan
FAKTOR KONTRIBUTOR : TIM	
Supervisi & Konsultasi	a. Adanya kemauan staf junior berkomunikasi b. Cepat Tanggap
Konsistensi	a. Kesamaan tugas antar profesi b. Kesamaan tugas antar staf yang setingkat
Kepemimpinan & Tanggung Jawab	a. Kepemimpinan Efektif b. Job Desc Jelas
Respon terhadap Insiden	Dukungan <i>peers</i> setelah insiden
FAKTOR KONTRIBUTOR : PETUGAS	
Kompetensi	a. Verifikasi Kualifikasi b. Verifikasi Pengetahuan & Keterampilan
Stressor Fisik dan Mental	a. Motivasi b. Stresor Mental: efek beban kerja beban mental c. Stresor Fisik : efek beban kerja = gangguan Fisik
FAKTOR KONTRIBUTOR : TUGAS	
Ketersediaan SOP	a. Prosedur Peninjauan & Revisi SPO b. Ketersediaan SPO c. Kualitas Informasi d. Prosedur Investigasi
Ketersediaan & akurasi hasil test	a. Test Tidak Dilakukan b. Ketidaksesuaian antara interpretasi hasil test
Faktor Penunjang dalam validasi alat medis	a. Ketersediaan, penggunaan, reliabilitas b. Kalibrasi
Desain Tugas	Penyelesaian tugas tepat waktu dan sesuai SPO
FAKTOR KONTRIBUTOR : PASIEN	
Kondisi Personal	Penyakit yang kompleks, berat, multikomplikasi a. Kepribadian b. Bahasa c. Kondisi Sosial d. Keluarga
Pengobatan	Mengetahui risiko yang berhubungan dengan pengobatan
Riwayat	a. Riwayat Medis b. Riwayat Kepribadian c. Riwayat Emosi
Hubungan Staf dan Pasien	Hubungan yang baik
FAKTOR KONTRIBUTOR KOMUNIKASI	
Komunikasi Verbal	a. Komunikasi antar staf junior dan senior b. Komunikasi antar Profesi c. Komunikasi antar Staf dan Pasien d. Komunikasi antar Unit Departemen
Komunikasi Tertulis	Ketidaklengkapan Informasi



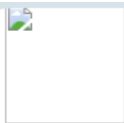
II. Akar Masalah dan Rekomendasi terhadap Insiden:

NO.	AKAR MASALAH	REKOMENDASI / SOLUSI
1.	Riwayat ANC ibu tidak direview secara holistik oleh bidan dan dokter SpOG di poli kandungan. Hasil protein urine dari Puskesmas (Positif 4) tidak terkaji dan direncanakan kontrol ulang	1. Setiap pasien ibu hamil harus dilihat Riwayat pemeriksaannya / di lihat buku KIA (Skrining di Poli Obgyn) 2. Jika ada yang menemukan proteinuria maka dirawat inapkan untuk mendapatkan terapi sesuai protap 3. Setiap Ibu hamil dengan ANC ke 1 bisa dicekkan DL, NCT, HbsAg, Sifilis 4. Review PPK (Panduan Praktik Klinis) ibu hamil dengan hipertensi
2.	Pelaporan diagnosis kepada DPJP kurang tepat, diagnosis yang disampaikan adalah PEB, bukan Impending Eklamsia. Kondisi pasien saat dilaporkan adalah dengan keluhan pusing (+), nyeri ulu hati (+), mual (+), muntah (-) Pemberian MgSO4 tidak langsung diberikan di IGD PONEK, namun saat pasien sudah di Maternitas	1. Peneguran dokter IGD terkait diagnosis sebelum pelaporan kepada dokter spesialis. 2. Jika ada pasien dengan tanda-tanda PEB/impending maka masuk MgSO4 fulldose langsung tanpa menunggu advice DPJP lalu direncanakan SC cito, tidak perlu menunggu pelaporan ke dokter spesialis, sesuai PPK/CP PEB
3.	Perbaiki SDM	Pelatihan drill emergency di Bulan November 2024 1. Dokter obgyn dan dokter anak sebagai pemateri 2. Sasaran peserta nya bidan dan perawat perinatologi

NB.* : Pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain
Saran : Baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselaman Pasien



ABSENSI



RS PRIMA HUSADA
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO, DESA LEMAHBANG KEC. SUKOREJO
KAB. PASURUAN
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Daftar Hadir
RAPAT RCA OKTOBER

Tempat : ANDALUSIA
Location

Tanggal dan : Kamis, 2024-10-24 09:00:00
Jam Thu, 2024-10-24 09:00:00
Date Time

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
1	Arindha Rahma Putri, S.Psi		administrasi		
2	Karunia Rizqi Nurandini, S.Tr.Keb	RS Prima Husada Sukorejo	Bidan		
3	Nurul Komariyah, Amd.Keb	RS Prima Husada Sukorejo	Bidan		
4	Novi Nur Cholifah, Amd.Keb	RS Prima Husada Sukorejo	Bidan		Novi Nur Cholifah
5	dr. dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG, Sp.OG	RS Prima Husada Sukorejo	Dokter Spesialis Obgyn		
6	Rofi'atal Manzilah, S.Psi	RS Prima Husada Sukorejo	HRD / SDM		Rofi'atal Manzilah
7	Tamara Putri Yunisma, S.Psi	RS Prima Husada Sukorejo	HRD / SDM	Tamara Putri Yunisma	
8	Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M. Kep	RSPHSKR	Kepala Bidang Pelayanan Medik RSPH Sukorejo		
9	Angela Wensi Flora Rosa	RSPHSKR	Kepala Ruang IGD Umum RSPH Sukorejo		
10	Siti Maysaroh, Amd.Kep	RSPHSKR	Kepala Ruang IRNA 3A RSPH Sukorejo		
11	Ninis indrawati	RSPHSKR	Kepala Ruang Maternitas RSPH Sukorejo		
12	- LIDIA PUSPITA KENCANA, S.K.M.	RS Prima Husada Sukorejo	Mutu		LIDIA PUSPITA KENCANA
13	Santoso Rahardjo, spog	Obgyn	PESERTA		

Malang, 25 Oktober 2024

arindha.raihan@gmail.com



NOTULENSI

HARI / TANGGAL : KAMIS/ 24 OKTOBER 2024
PUKUL : 13.00 WIB – 15.00 WIB
JENIS MEETING : RCA INVESTIGASI KOMPREHENSIVE TERKAIT PEB NY. SUMIATI
TEMPAT : RUANG ANDALUSIA LANTAI 3

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1.	Pokok Bahasan : RCA Investigasi Komprehensif Terkait PEB Ny Sumiati Masalah : - Faktor Kontributor dari DPJP: - Dokter Santoso tidak mengkonsulkan pemberian Obat MgSO4 ketika pasien dengan Tanda-tanda PEB masuk ke IGD - Dokter Santoso tidak mengetahui diagnosa nyeri ulu hati, mual dan muntah pada kondisi awal pasien (sudah ada diagnosa tersebut sejak pertama kali masuk ke IGD) - Tidak mengetahui pemberian SM 20% fulldose - Keterbatasan pengetahuan dokter obgyn dalam penanganan kegawat daruratan pasien - Faktor Kontributor Organisasi dan Manajemen RS Prima Husada Sukorejo: - Belum ada kebijakan mengenai Serangkaian tes laboratorium dalam ANC Trimester 1 yang di tanggung oleh BPJS - Belum ada SPO terkait Pemberian Antihipertensi untuk ibu hamil dengan multiple gravida - Belum ada kebijakan yang mengatur Semua DPJP (Dokter Obgyn) dalam pasien dengan PEB harus diberikan MgSO4 secara keseluruhan dengan target 100%. - Belum ada pelatihan terkait drill emergency baik untuk dokter obgyn, dokter anak, bidan dan perawat neonatologi - Belum ada Aturan dengan Pemasangan CPAP pada bayi dengan kondisi kegawat daruratan - Belum ada CP untuk PEB dan HPP - Dalam Pelayanan Eracs, dari 10 pasien yang diobservasi oleh DPJP, 8 pasien masih mengeluhkan rasa sakit - Dokter Obgyn yang perlu ditambahkan - USG 4D untuk soft file belum bisa diberikan kepada pasien sehingga belum pernah ada income dari USG 4D. - Faktor Peralatan/Sarana/Prasarana di RS Prima Husada Sukorejo: - Ruang Ponek IGD dengan jumlah pasien tidak sesuai dengan standar - Trolli Emergency (Set Emergency) di Ponek IGD belum dilengkapi
	Keterangan : -
	PIC : - dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS - Direktur RSPH Sukorejo - Heni Indra Wulansari, S.Kep.Ns, M.Kep - Kabid Pelayanan - Dwi Novianti. A.Md.AK., S.Kes – Kabid Penunjang - Siti Maysaroh, Amd. Kep – Kabid Keperawatan - Angela Wensi Flora Rosa, S.Kep.,Ns – PLT Kabid Pelayanan - Rhizqita Julian Eka Rahmanda, Amd. PK., S.KM – PLT Wakil Kabid Penunjang - Novia Ainur Pratiwi, S.KM. – Kepala SDM - dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD – Komite Medik - Rofi'atal Manzilah, S.Psi – Sekre Komdik & Diklat - dr. Santoso Rahardjo, Sp.OG (DPJP) - dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG (Dokter Obgyn) - Ninis Indrawati, S.Tr. Keb. (Karu Maternitas) - Novi Nur Cholifah, Amd. Keb (Bidan Ponek) - Karunia Rizqi Nurandini, S.Tr.Keb (Bidan Maternitas) - Nurul Komariyah, Amd. Keb (Bidan Maternitas)



Rencana Tindak Lanjut :

1. Faktor Kontributor dari DPJP:

- a. Pelatihan Drill Emergency dengan Narasumber dokter Rudi dan dokter anak, dan dijadwalkan di Bulan November 2024. Adapun sasaran peserta pelatihan:
- 1) Bidan
 - 2) Perawat Neonatologi
 - 3) Dokter Obgyn RS Prima Husada Sukorejo
 - 4) Dokter Anak RS Prima Husada Sukorejo

2. Faktor Kontributor Organisasi dan Manajemen RS Prima Husada Sukorejo:

- a. Serangkaian tes laboratorium dalam ANC Trimester 1 dapat diajukan dengan pemeriksaan sesuai SDIH. Adapun macam-macam pemeriksaan antara lain:
- 1) Darah Lengkap
 - 2) HbsAg
 - 3) Sifilis
 - 4) HIV
 - 5) Urine Lengkap

Adapun pengajuan di ajukan ke PT untuk ACC harga pemeriksaan

- b. Pembuatan PPK untuk Pasien PEB yang mengatur diantaranya:
- 1) Tatalaksana PPA dalam pelayanan pasien dengan PEB (Dokter, Bidan, Gizi dan Farmasi)
 - 2) Pemeriksaan Penunjang yang wajib ada yakni:
 - a) Darah Rutin & Urin Lengkap
 - b) Fungsi Hati (SGOT/PT)
 - c) Ureum Creatinine (Fungsi ginjal)
 - d) Albumin
 - e) GDS
 - f) Faal Hemostasis
 - g) LDH
 - h) USG
 - i) EKG
 - 3) Pemeriksaan Penunjang yang bila perlu:
 - a) Serum Elektrolit (Na, K, Cl)
 - b) Cardiotocography (CTG), bila UK > 28 minggu
 - c) X-ray thoraks PA
 - 4) Adapun hal yang mengatur obat yakni:
 - a) Awasi Airway , Breathing dan Circulation
 - b) Obat anti kejang: MgSO4 40%
 - Dosis awal (full dose : 40% 4gr(10cc) dilarutkan dalam 10 cc WI atau NS dimasukkan secara IV 10-15 menit, sisanya 6 gr MGso4 40% (15cc) dimasukkan dalam NS atau RL 500ml dengan tetesan 28 tpm atau habis dalam 6 jam.
 - Bila terjadi kejang ulangan beri 2gr MgSO4 40% dilarutkan pada WI atau NS 10cc.Monitoring tanda-tanda keracunan MgSO4
 - c) Perawatan pada serangan kejang :
 - Dirawat di kamar isolasi yang cukup terang.
 - Masukkan spatel lidah antara lidah dan gigi rahang atas
 - Kepala direndahkan, daerah orofarings dihisap
 - Fiksasi badan pada tempat tidur harus cukup kendor guna menghindari fraktur.
 - d) Perawatan penderita dengan koma :
 - Monitoring kesadaran dan dalamnya koma dengan menggunakan "Glasgow Pittsburgh Coma Scale".
 - Pada perawatan koma, perlu diperhatikan pencegahan dekubitus dan makanan penderita.



- Pada koma yang lama, bila nutrisi tidak mungkin cukup diberikan dalam bentuk nasogastric tube
- e) Terapi lain
 - Injeksi :
 - ✚ Cefazolin 2x1 Gr IV
 - ✚ Furosemid 1x40 mg IV
 - ✚ Ocytocin 2 amp IV
 - ✚ Metoclopramid 3x10mg IV
 - ✚ Ketorolac 3x30mg IV
 - ✚ Ranitidine 2x50mg IV
 - ✚ Kalnex 3x500mg IV
 - Per oral :
 - ✚ Clindamycin 2x300mg PO
 - ✚ Rob 1x1 tab PO
 - ✚ Asam Mefenamat 3x500mg PO
 - ✚ Nifedipin 3x10mg PO
 - ✚ Metildopa 3x500mg PO

Adapun harga pemeriksaan masih diajukan ke PT

- c. Pelatihan Drill Emergency dengan Narasumber dokter Rudi dan dokter anak, dan dijadwalkan di Bulan November 2024. Adapun sasaran peserta pelatihan:
 - 1) Bidan
 - 2) Perawat Neonatologi
 - 3) Dokter Obgyn RS Prima Husada Sukorejo
 - 4) Dokter Anak RS Prima Husada Sukorejo
 - d. SPO Pemasangan CPAP pada bayi dengan kondisi kegawat daruratan
 - e. Pembuatan CP PEB dan HPP (Kabid Pelayanan, Kabid Keperawatan, Komte Medik)
 - f. Review Ulang Pelayanan Eracs:
 - 1) Obat-obatan dalam Pelayanan Eracs
 - 2) Harga Pelayanan (Obat-obatan)
 - 3) BPJS kelas 1,2 yang bisa mengcover pelayanan eracs
 - g. Rekrutmen Dokter Obgyn oleh SDM
 - h. Konfirmasi ke PT terkait Alat USG 4D yang tidak mencetak soft file
- 3. Faktor Peralatan/Sarana/Prasarana di RS Prima Husada Sukorejo:**
- a. Perluasan IGD dengan gedung baru dalam tahap pembangunan, dengan rencana ruang IGD Ponek 4 TT
 - b. Pengajuan Set dan Troli Emergency dari Ponek melalui SIMRS

Pasuruan, 24 Oktober 2024

Mengetahui
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

Pemimpin Rapat

Lidia Puspita Kencana, S.K.M.



DOKUMENTASI

